

28 - 04- Gros reins - Pr. Lakmichi

L'égoraphe, c'est ainsi une clinique d'une extrême importance en urologie. Elle constitue une circonstance découverte de plusieurs pathologies de l'orgue par parait urinaire que nous allons voir. L'anamnèse et les examens cliniques occupent une place primordiale dans la démarche diagnostic.

Les examens paracliniques, ils orientent, confirment l'étiologie en cause. Les circonstances découvertes, le maître symptôme, c'est la masse lambo-abdominale. Et par conséquent, on doit s'attacher à réaliser un examen physique bien conduit.

Cette masse lambo-abdominale, elle peut s'accompagner d'un cortège de signes cliniques. En l'occurrence, l'hématurie, la douleur lambaire, des coliques néphritiques, des infections urinaires à réposition avec les pueries, un tableau fébrile, un tableau d'altération d'état général associé à une hypertension artérielle, émission spontanée de calculs urinaires, et en dernier lieu, les trous de mycélite. Comme vous voyez, la masse lambo-abdominale, la masse lambaire, le gros rein, peut être accompagnée avec des signes qui sont très très riches.

Alors l'hématurie, en premier lieu l'échographie rénale, suivie par le maître examen paraclinique, qui est l'uroscanère, sont d'une extrême importance. C'est comment ? En connaissant un gros rein. Alors tout d'abord, l'examen clinique des fausses lambaires, comme on a vu au cours de l'examen physique.

On cherche présentement une vossure au niveau de la fausse lambaire. On cherche un contact lambaire, un ballotement rénal, et un signe qui est assez rare, qui est la sonorité colique, qui barre en avant la masse. On essaie de chercher les caractères de ce gros rein.

Il faudra savoir déterminer le volume, évaluer le volume, évaluer ses consistances, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est rémitante. Évaluer la mobilité par rapport aux deux plans antérieur et postérieur en ballottant la masse, c'est-à-dire la fixité. Et estimer la douleur provoquée lors de l'examen qui est facilement évoquée.

Et ne pas oublier l'examen complet du patient, à savoir la prise des consistances, la température, la tension artérielle, et terminer l'examen physique par les touches épaisses. Diagnostic différentiel. On trouve une dose rénale qui est, sur un certain sens, assez exceptionnelle, qui est rencontrée sur le sujet maigre.

En deuxième lieu, les tumeurs surrénales, les sphénomégalies ou hépatomégalies, les tumeurs de la queue du pancréas, ou bien les tumeurs digestives. La démarche diagnostique. Tout d'abord, le socle du diagnostic, on doit rester clinicien, et donc c'est l'anamnèse et l'examen clinique, suivi par l'échographie, qui est un examen anodin, qui utilise des ultrasons qu'on trouve à peu près partout, et qui donne souvent des renseignements très précieux.

Cette échographie va nous orienter vers une masse rénale tumorale solide, vue son échogénicité tissulaire, ou bien vers une masse rénale qui stique, avec présence d'un liquide qui transmet pleinement les ultrasons, ou bien une hydronephrose, c'est-à-dire un rein qui est dilaté au namen d'un obstacle, et par conséquent, il augmente son volume, ou bien un gros rein qui est infecté, présente d'une pionephrose. Les autres examens d'imagerie, une radiologie standard, l'arburine à son préparation, qui peut démontrer la présence d'une image de densité calcique se projetant sur l'air urinaire, témoignant d'un obstacle lithiasique. L'uroscanner, qui est le maître examen en matière de masse rénale, suivi par l'urIRM, qui est l'imagerie par résonance magnétique.

C'est un examen qui est très performant et qui a connu ces dernières années une grande réussite en urologie pour caractériser les masses rénales. Les diagnostics urologiques des gros reins, c'est-à-dire les causes des gros reins, il y a les gros reins tumoraux, ou simplement les tumeurs rénales. Ces tumeurs rénales peuvent être soit pénines, soit malignes.

La clinique, plus souvent, est asymptomatique, ou bien le signe le plus important, c'est une bouleur, un type de pesanteur. Associée exceptionnellement à une haine maturée. Les examens complémentaires, c'est à chaque fois l'échographie uroscannaire, plus souvent.

Et rarement, on réalise des uoIRM en cas de doute. L'échographie, en cas de tumeur rénal, masse rénale tumorale, nous montre des masses denses ou hétérogènes quand il y a des zones de nécrose. Si l'échographie oriente vers le diagnostic de masse solide, elle ne permet pas le diagnostic de nature maligne.

L'uroscannère, ou la TDM, avec injection de produits de contraste, est la méthode de choix, à la fois pour le diagnostic et le bilan d'extension des tumeurs rénales. Son rôle est d'une part de confirmer l'existence d'une tumeur, à l'autre part de faire un bilan loco-régional. Une chose très importante, c'est qu'il y a un comportement concernant les tumeurs rénales.

Il y a un comportement vasculaire qui est assez caractéristique des tumeurs rénales. Par contre, vous le savez, les tumeurs rénales sont très vascularisées. Les étapes de l'uroscannère, premièrement, on réalise des coupes sans injection de produits de contraste, suivies par la suite des coupes après injection de produits de contraste.

Qu'est-ce qu'on remarque après injection de produits de contraste en présence des tumeurs rénales ? On remarque la présence d'un rehaussement qui est très important de la masse rénale. Du fait d'une vascularisation qui est très riche et très importante de la tumeur, et par conséquent, elle prend beaucoup plus de produits de contraste par rapport au reste du parenchyme rénal normal. Et donc, on parle du signe de rehaussement.

Généralement, c'est mesuré par les unités Ospine. Nous allons voir ça dans les examens parachymiques et c'est un signe assez caractéristique des tumeurs rénales. L'imagerie par résonance magnétique, elle est indiquée en cas d'insuffisance rénale car le produit de contraste

utilisé n'est pas néfrotoxique.

En cas d'allergie à l'iode, et également en cas de contre-indication à l'utilisation des radiations immunisantes, le cas des patients enceintes. Elle permet la détection et la caractérisation des toutes petites masses suspectes et indéterminées en TDM. Elle permet aussi, comme la TDM, le bilan d'extension des tumeurs.

Là, c'est une image d'imagerie par résonance magnétique montrant une volumineuse tumeur rénale avec une extension de la tumeur au niveau de la veine. Là, c'est une pièce de néphrectomie élargie pour tumeur rénale. C'est un aspect macroscopique d'un carcinome à cellules rénales du pôle inférieur du ras, montrant le tissu tumoral de couleur jaune et siège de remaniement hémorragique et fibruleux.

L'aiguillon kystique, toujours à l'horoscaner, peut être des kystes simples serreux du ras, ou bien des kystes hidatiques du ras, c'est une pathologie parasitaire, qui peuvent se localiser au niveau du ras et se manifester sous forme de kystes rénales, ou bien des polykystoses, ou bien une polykystose rénale. Les kystes serreux du ras. L'incidence augmente avec l'âge.

Plus de 50% des patients âgés de plus de 50 ans présentent des kystes simples du ras, limités par un mur fibreux tapissé par un épithélium plat et ne présentant aucun élément rénal. Les kystes serreux du ras, sur plan simiologique, donnent rarement une hématurie. Ils donnent souvent des lombalgies, mais lorsqu'ils atteignent un volume qui est très important, au-delà de 7-8 cm, généralement, ils commencent à faire parler d'eux, sur plan simiologique.

Et des gros ras, qui sont petits. Là, c'est une image échographique d'un gros kyste rénal, comme vous voyez. Le liquide en échographie, on le voit en noir.

Et les ultrasons, quand ils traversent ce liquide, ils vont buter contre le parenchyme derrière, et donc nous donner une image de renforcement postérieur. Le renforcement postérieur, c'est-à-dire le parenchyme derrière qui devient blanc. C'est assez spécifique des masses liquidiennes à l'échographie.

Ça, c'est un petit kyste 5 du rin gauche. Là, c'est une image scanographique, c'est-à-dire un uroscanner d'un kyste 5 du rin droit. Les kystes didactiques du rin, par définition, c'est une localisation, comme on l'a dit, rénale d'un parasite didactique.

Ce parasite didactique, son nom scientifique, c'est le *Thénia echinococcus*. Cliniquement, ils vont nous donner le tableau d'un kyste rénal, des lombalgies, des grands reins. Mais en plus de ça, elles donnent un signe qui est assez pathogénomique, c'est-à-dire spécifique à la pathologie didactique rénale, c'est-à-dire l'émission dans les urines des débris didactiques, ce qu'on appelle l'idaturie, c'est-à-dire que les morceaux de la paroi de ces kystes didactiques vont être éliminés dans les cavités excrtrices.

Et vous imaginez bien, ils vont éroder la cavité excritrice et donc donner rarement les matures. Le kyste didactique du rin, l'examen complémentaire, c'est l'échographie, nous donne des lésions kystiques, un uroscanner des masses kystiques qui ne prennent pas le produit de contraste. La polykystose rénale, par définition, c'est une maladie congénitale caractérisée par l'édification de plusieurs kystes au niveau des deux reins.

L'évolution se fait lentement vers l'insuffisance rénale, parce que c'est une pathologie qui intéresse les deux reins, c'est généralement le nombre de plusieurs kystes au niveau des deux reins à la fois, et donc ce que décrivent les anglo-saxons par sponge kidney, c'est-à-dire rein éponge, c'est plusieurs petits kystes au niveau des reins, de telle sorte que ce rein devient comme un éponge, et on comprend bien la destruction lente et insidieuse des glomérules et des néphrons, devant donc reculer le malade à une insuffisance rénale chronique seconde. Cliniquement, c'est une bouloir, l'œdème abdominale, avec des hématuries, et là l'hématurie est plus présente dans ce tableau-là de polykystose rénale. Les deux reins sont gros, bosselés et palpables.

L'examen complémentaire, c'est l'échographie qui va objectiver les lésions kystiques, cette fois-ci bilatérales. L'ATDM des masses kystiques ne prend pas le produit de contraste de façon bilatérale. L'autre étiologie sont les gros reins dilatés, c'est en fait l'hydronephrose.

C'est une dilatation des capillaires rénales, en amont d'un obstacle le plus souvent en lithiasique. Les syncliniques, c'est en fonction de l'étiologie. Et les examens paracliniques, c'est bien entendu essentiellement l'hématurie, l'échographie, l'uro-TDM ou l'uro-IA.

Les principales étiologies, c'est en premier lieu l'étiologie malformative, congénitale. On cite ici le syndrome de jonction plurirétérale, c'est-à-dire une anomalie au niveau de la jonction plurirétérale qui fait que cette jonction se rétrécisse, et ça de façon congénitale. Un obstacle lithiasique, un calcul qui se trouve au niveau de la cavité, au niveau de la jonction, au niveau de la cavité urétérale jusqu'aux nerfs, et qui va obstruer sa lumière et par la suite induire une dilatation en amont.

Ou bien l'obstacle tumoral qui peut induire une dilatation en amont aussi. Là, c'est une urographie intraveineuse, c'est un cliché d'urographie intraveineuse fait juste après un uro-scanner. C'est un patient âgé de 30 ans, qui a eu une découverte lors d'une colique néphrétique.

Cliché à 5 heures, il montre une importante dilatation de pelvicalice sans dilatation des cavités et de ses franges. Et ça, c'est bon, vous voyez, blanche, c'est le bassin qui est dilaté parce que la jonction plurirétérale est complètement sténosée. On parle de syndrome de jonction plurirétérale.

Les gros reins infectés, c'est en fait la pyélonéphrose. La pyélonéphrose, c'est un gros rein infecté avec des cavités rénales infectées, sont pleines de pus. Il faut opposer la pyélonéphrose à l'hydronephrose infectée.

Alors la pyélonéphrose, c'est un rein qui a été obstrué, dont les cavités sont pleines de pus. Et

donc ce pus, il a rongé le panchyme rénal qui est complètement détruit, tournant le rein, rendant le rein comme une poche de pus. Ça, c'est la pionnéphrose, une destruction turbulente du panchyme rénal secondaire, mais plus ou moins un obstacle.

A l'opposé de l'hydronéphrose infectée, qui est sa phase initiale, c'est juste un rein qui est obstrué avec des urines intra-rénales. Qui sont infectées. Et ça, c'est une des premières phases vers la pionnéphrose.

La clinique, c'est un gros rein douloureux avec un syndrome infectieux très important, qui est 39-40 degrés. Un patient avec un teint infectieux, teint terreux, avec une altération de l'état général. C'est une infection profonde avec une purpurie.

La biologie, qui est très parlante, avec une hyperleucocytose à la numération en formule, plus souvent associée à une anémie. Le CBU avec des urines infectées. La radiologie, l'échographie et le neuroscanner sont les maîtres examens radiologiques pour faire le diagnostic de pionnéphrose.

Les étiologies, le plus souvent, sont des obstacles d'infection. L'écoulement infecté toujours. Il y a le fléguement périnéphritique.

Le fléguement périnéphritique, par définition, c'est un abcès constitué dans la loge rénale. C'est à partir d'un abcès rénal. C'est un abcès rénal qui va se rendre au sein de la loge rénale.

Il est donc donné le fléguement périnéphritique. Et là, le tableau, il est encore plus parlant. C'est un état éphébril avec des frissons.

C'est un état du cétis avec une douleur plus sévère de la fosse lombaire. Un autre pattement douloureux avec une rougeur de la paroi lombaire et un œdème de la paroi lombaire. Et parfois présente des fistules de la fosse lombaire.

Ce sont des tableaux qui sont actuellement historiques. L'examen, l'examen d'imagerie. Le premier, c'est toujours l'échographie.

Il tourne autour de l'échographie et du neuroscanner. En conclusion, le grand Rhin est un signe symptomatique très important en neurologie. Il faudrait savoir le reconnaître.

L'examen clinique. Comme vous avez vu, les idéologies sont très variables et diverses. Et les signes symptomatiques accompagnateurs, il faudrait faire très attention.

Car, il pourrait orienter vers un ou des idéologies probables. Merci.